

Cuerpos extraños del conducto auditivo externo

1. Introducción y relevancia clínica

La **presencia de un cuerpo extraño (CE)** en el **conducto auditivo externo (CAE)** es una situación **frecuente en pediatría**, aunque también puede observarse en adultos, especialmente en pacientes con **trastornos psiquiátricos, demencia o uso de dispositivos auditivos**.

En Chile, es una **consulta habitual en urgencias y atención primaria**, representando hasta el **10% de las atenciones ORL pediátricas**.

Si bien la mayoría son benignos y de resolución sencilla, una manipulación inadecuada puede producir **lesiones graves**, como:

- **Perforación timpánica.**
- **Otitis externa secundaria.**
- **Hemorragia o vértigo.**

El manejo oportuno, bajo **visualización directa** y con técnica adecuada, evita complicaciones y la necesidad de derivación a un especialista.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El **conducto auditivo externo (CAE)** es una estructura estrecha, de forma sigmoidea, con una porción cartilaginosa externa (1/3) y una porción ósea interna (2/3).

El tamaño y curvatura hacen que los cuerpos extraños queden **impactados**, especialmente si se introducen con fuerza o intentan extraerse sin visualización.

2.1 Mecanismo de impacto

- En niños: introducción voluntaria por curiosidad (semillas, bolitas, papel).
- En adultos: accidental (tapones, audífonos, prótesis, insectos).
- En ancianos o pacientes con déficit cognitivo: causas autoinfligidas o iatrogénicas (algodón, cerumen impactado por manipulaciones).

2.2 Clasificación según naturaleza del cuerpo extraño

Tipo	Ejemplos	Consideraciones clínicas
Inanimado no vivo	Semillas, bolitas, plástico, metal, goma, papel	Pueden obstruir completamente el CAE
Animado (vivo)	Insectos (moscas, hormigas, cucarachas)	Generan dolor intenso y vértigo; requieren inmovilización inmediata
Orgánico (vegetal)	Frijoles, lentejas, maíz, porotos	Tienden a hincharse con el agua → NO irrigar
Inorgánico	Plásticos, metales, baterías de botón	Riesgo de lesión química o necrosis si son pilas

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas más frecuentes

Dependen del tipo, tamaño, tiempo de permanencia y grado de impacto:

Síntoma	Frecuencia	Explicación
Hipoacusia conductiva	Muy frecuente	Obstrucción del CAE
Sensación de oído tapado / plenitud	Frecuente	Bloqueo mecánico

Dolor (otalgia)	Moderado a severo	Irritación o laceración
Prurito	En cuerpos pequeños o vegetales	
Otorrea	Si hay infección secundaria	
Sangrado (otorragia)	Por manipulación o trauma	
Tinnitus o vértigo	En contacto con el tímpano o insectos	

En insectos vivos: el paciente puede referir **zumbido, movimientos internos o dolor agudo punzante**.

3.2 Examen físico (otoscopía)

Hallazgos:

- Cuerpo extraño visible, único o múltiple, en CAE.
- Puede estar móvil o firmemente impactado.
- Piel del conducto eritematosa, con edema o secreción.
- Tímpano habitualmente **íntegro**, aunque puede estar oculto.

Evitar explorar en exceso si hay dolor o riesgo de perforación.

3.3 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico

Diferencias principales

Tapón de cerumen	Color marrón oscuro, pastoso, no sólido ni brillante
------------------	--

Otitis externa	Dolor al traccionar pabellón, sin objeto visible
----------------	--

Colesteatoma del CAE	Detritus blanquecino y mal olor, erosión ósea
----------------------	---

Otitis media con otorrea	Secreción purulenta sin cuerpo extraño visible
--------------------------	--

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico es **clínico y visual**.

Generalmente **no se requieren exámenes complementarios**, salvo complicaciones.

Indicación	Examen	Finalidad
Sospecha de perforación timpánica o lesión ósea	Otoscopía bajo microscopio o endoscopía	Confirmar daño
CE no visible o profundo	TAC de peñasco sin contraste	Ubicación y extensión
Sospecha de batería de botón o material metálico	Radiografía simple de cráneo / mastoides	Confirmación rápida

Criterios diagnósticos:

1. Presencia visual de objeto dentro del CAE.
2. Síntomas compatibles (otalgia, hipoacusia, otorrea).
3. Correlación anatómica con hallazgos otoscópicos.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El objetivo del tratamiento es **remover el cuerpo extraño sin causar daño adicional**, preservando la integridad del tímpano.

El **método de extracción depende del tipo de objeto, su localización y el paciente.**

5.1 Principios generales

- **No intentar extracción a ciegas.**
 - **Evitar múltiples intentos fallidos**, ya que aumentan riesgo de perforación.
 - **Mantener calma y buena iluminación.**
 - En niños: puede requerirse **inmovilización o sedación ligera.**
 - En insectos: **matar primero al animal antes de extraerlo.**
-

5.2 Extracción de objetos no vivos

Métodos disponibles:

Método	Indicaciones	Técnica / Observaciones
Pinzas o fórceps auriculares	Objetos visibles y accesibles (algodón, papel, plástico)	Tomar con delicadeza; evitar comprimir contra el CAE
Ganchos o lazos metálicos	Objetos redondeados no frágiles	Requieren experiencia y buena visión
Sonda con succión (aspiración)	Objetos pequeños o móviles	Ideal en servicios ORL

Irrigación con agua tibia (37°C)	Objetos no vegetales, no pilas, no fragmentables	Dirigir chorro posterior-superior, no al tímpano
Cureta bajo visión directa	En cuerpos blandos o adherentes	Evitar si paciente se mueve

Contraindicaciones absolutas a irrigación:

- Cuerpo **vegetal** (se expande con el agua).
- Cuerpo **punzante o cortante**.
- Sospecha de **perforación timpánica**.
- **Baterías de botón**.

5.3 Extracción de insectos (vivos)

1. Inmovilización inmediata:

- Instilar **alcohol al 70%, lidocaína viscosa o aceite mineral tibio** para matar el insecto.
- No usar agua fría (puede inducir vértigo).

2. Extracción posterior:

- Una vez muerto, retirar con pinza o irrigación cuidadosa.
- Evaluar integridad timpánica.

5.4 Extracción de pilas (baterías de botón)

Emergencia otorrinolaringológica.

- Remover **de inmediato**, sin irrigación, ya que el contacto produce **necrosis química (hidróxido alcalino)** y **perforación timpánica en horas**.

- Si no puede retirarse en APS → **derivar de urgencia a ORL.**

5.5 Tratamiento posterior a la extracción

1. Revisar **integridad del conducto y tímpano.**
2. Si hay **erosión, sangrado o secreción**, aplicar:
 - Gotas antibióticas tópicas (ciprofloxacino o polimixina-neomicina).
 - Analgésicos VO según dolor.
3. Si hay **perforación o sospecha de otitis externa secundaria** → derivar a ORL.
4. Evitar agua y manipulación por 48 h.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo	Prevención
Laceración del CAE	Manipulación inadecuada o instrumento rígido	Visualización directa y técnica suave
Perforación timpánica	Irrigación excesiva o contacto directo	Evitar chorro frontal o extracción brusca
Otitis externa	Contaminación o trauma	Gotas antibióticas postextracción
Hemorragia	Lesión capilar del CAE	Presión local suave
Vértigo / náuseas	Irrigación con agua fría	Usar agua tibia

**Necrosis química
(pilas)**

Reacción cáustica alcalina

Extracción inmediata sin
irrigar

Pronóstico:

Excelente si se maneja correctamente.

La mayoría de los pacientes quedan asintomáticos tras la extracción, con mínima o nula secuela auditiva.

Las complicaciones graves son excepcionales y casi siempre iatrogénicas.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. En **niños pequeños**, la causa más frecuente de otalgia o hipoacusia unilateral es un **cuerpo extraño**.
2. **Nunca irrigar cuerpos vegetales o pilas.**
3. **Insectos vivos** deben **matarse antes de intentar retirarlos**.
4. Si el cuerpo está muy profundo o impactado → **derivar a ORL sin intentos repetidos**.
5. Después de la extracción, revisar el **tímpano** siempre.
6. En caso de **otorrea fétida o persistente postextracción**, sospechar **otitis externa secundaria**.
7. En adultos con déficit cognitivo o dolor persistente sin causa visible, pensar en **CE residual o lesión del CAE**.

Errores comunes

- Intentar extracción a ciegas sin iluminación.
- Irrigar cuerpos vegetales o pilas.

- No revisar integridad timpánica tras extracción.
 - Manipular repetidamente generando sangrado o trauma.
 - No administrar tratamiento tópico posterior cuando hay lesión del CAE.
 - No derivar a ORL en casos difíciles o dolorosos.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Los **cuerpos extraños del CAE** son frecuentes, sobre todo en **niños y pacientes con alteraciones cognitivas**.
2. El diagnóstico es **visual y clínico**, mediante otoscopía.
3. El manejo depende del tipo de objeto: **pinzas, succión o irrigación selectiva**.
4. **Nunca irrigar objetos vegetales o pilas** (riesgo de edema o necrosis).
5. En insectos vivos, se debe **matar al animal antes de retirarlo**.
6. Revisar siempre la **integridad del tímpano** postextracción.
7. **Derivar a ORL** si hay perforación, fracaso del intento o sospecha de lesión.